Centre Hospitalier Intercommunal du Val-de-Lys
Pôle Cœur-Vaisseaux — Service de Cardiologie
12, avenue des Tilleuls — 59870 Marchiennes-sur-Lys — Tél. 03 27 00 41 18

Compte rendu d'hospitalisation

Destinataire : Dr Hélène Marchal, médecin traitant, 4 rue du Moulin, 59870 Marchiennes-sur-Lys

Patient	M. BARRAULT Lucien
Date de naissance	12/03/1951 (75 ans)
N° de séjour	26-118304
Entrée	14/09/2026, par les urgences
Sortie	19/09/2026, retour à domicile
Médecin responsable	Dr Antoine Vasseur

Chère Consœur,

Je vous adresse le compte rendu de l'hospitalisation de votre patient, M. Lucien Barrault, admis dans notre service du 14 au 19 septembre 2026.

Motif d'hospitalisation

Le patient a été admis pour une décompensation cardiaque globale sur fibrillation atriale rapide de découverte récente.

Antécédents

- Hypertension artérielle traitée depuis 2009
- Diabète de type 2 sous metformine, HbA1c à 7,4 % en juin 2026
- Cardiopathie ischémique : angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure en 2018
- Ancien fumeur (30 paquets-années), sevré depuis 2015

Histoire de la maladie

Depuis trois semaines, M. Barrault décrivait une dyspnée d'effort d'aggravation progressive, associée à des œdèmes des membres inférieurs. À l'admission, la fréquence cardiaque était à 138 battements par minute et la saturation à 91 % en air ambiant. La radiographie thoracique objectivait une surcharge hydrostatique bilatérale.

Examens complémentaires

Biologie

Examen	Résultats		Unité	Valeurs usuelles
	J1 (14/09)	J5 (18/09)		
NT-proBNP	4 870	1 920	pg/mL	< 450
Créatinine	118	104	µmol/L	62 – 106
Potassium	3,6	4,2	mmol/L	3,5 – 5,0
Hémoglobine	12,9	12,6	g/dL	13,0 – 17,0
TSH	2,1	—	mUI/L	0,4 – 4,0

Imagerie

L'échocardiographie transthoracique du 15 septembre retrouve une fraction d'éjection ventriculaire gauche estimée à 40 %, sans valvulopathie significative.

Évolution

Sous diurétiques intraveineux, l'évolution a été favorable avec une perte de poids de 4,2 kg en cinq jours. Un traitement anticoagulant a été instauré après évaluation du risque hémorragique. Une stratégie de contrôle de la fréquence a été privilégiée ; la cardioversion sera discutée à distance.

Traitement de sortie

Médicament	Posologie	Remarque
Apixaban 5 mg	1 comprimé matin et soir	Nouveau
Bisoprolol 5 mg	1 comprimé le matin	Dose augmentée
Furosémide 40 mg	1 comprimé le matin	Nouveau
Ramipril 2,5 mg	1 comprimé le soir	Inchangé
Metformine 1 000 mg	1 comprimé matin et soir	Inchangé
Atorvastatine 40 mg	1 comprimé le soir	Inchangé

Suivi proposé

- Ionogramme sanguin et créatininémie dans 7 jours
- Consultation de cardiologie le 21 octobre 2026 à 10 h 30
- Échocardiographie de contrôle dans 3 mois
- Pesée quotidienne ; reconsulter en cas de prise de plus de 2 kg en trois jours

Je vous remercie de m'avoir confié ce patient et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien confraternellement,

Dr Antoine Vasseur
Praticien hospitalier — Cardiologie